

探討加護病房中家屬創傷後壓力 症候群（ PTSD ）之多重觸發因 子

—— 一項質性主題分析研究

報告場景：ICU 晨會學術報告

報告人：ICU 專門醫師

報告時間：約 30 分鐘

文獻來源：

"It was torture for him, and it was torture for us to see him like that": understanding multiple ICU-related triggers of family PTSD symptoms—a qualitative thematic study

研究背景與臨床痛點 (Background & Rationale)

加護病房 (ICU) 患者家屬面臨極高的心理負擔，這被定義為 加護病房後綜合氏症候群-家屬 (PICS-F) 。

1. 高心理負擔與 PTSD 盛行率

- ICU 患者家屬在患者出院或死亡後數月內，焦慮與憂鬱極為常見。
- 創傷後壓力症候群 (PTSD) 的盛行率高達 10% – 69%。
- PTSD 核心症狀包括：侵入性記憶 (閃回)、迴避行為、情緒麻木以及過度警覺，嚴重影響日常功能。

2. 文獻空白與研究切入點

- 現有研究多為定量研究，著重於非可控的危險因素 (如人口統計學、疾病嚴重度指標)。
- 缺乏深入探討「家屬在 ICU 期間的具體經歷如何轉化為創傷體驗」的微觀機制。
- 深入理解家屬視角下的「創傷觸發點 (Triggers)」，有助於 ICU 醫療團隊發展具體可行的預防性介入措施。

研究目的 (Study Objectives)

本質性研究的核心目的在於從家屬的自述經驗中，釐清創傷形成的細節與臨床介入機會。

主要目標

探索在 ICU 期間經歷高度壓力且在出院或死亡後 3 個月出現顯著 PTSD 症狀之家屬的微觀經歷。

次要目標

- 識別 ICU 治療各階段中（從入院、適應環境到臨終）常見的創傷觸發因子（ICU-phase triggers）。
- 評估醫療團隊的溝通、臨床處置及病房環境對緩解或加劇創傷的影響。
- 為重症醫學團隊提供優化「以家庭為中心（Family-centered care）」照護的實務指南。

研究方法 (Research Methodology)

本研究是法國一項大型多中心前瞻性定量研究的質性研究分支。

1. 研究設計與對象

- 採用深度半結構式訪談 (Semi-structured interviews) 與主題分析法 (Thematic analysis) 。
- **患者條件**：入住 ICU 且接受侵入性機械通氣 (MV) ≥ 48 小時的成年患者。
- **家屬篩選**：出院/死亡 3 個月後，接受 PCL-5 (PTSD 量表) 篩檢。
- **納入對象**：PCL-5 篩檢呈陽性 (在 B、C、D、E 各症狀群組中至少有一項中度以上症狀，代表具臨床顯著症狀的家屬) 。

2. 資料收集與分析

- 訪談時間點安排在患者 ICU 出院或死亡後的 **6 個月** (避開急性創傷期) 。
- 訪談平均時長為 **1 小時 38 分鐘** (全程錄音並逐字轉錄) 。
- 四步驟主題分析法：學者獨立編碼 $\rightarrow$ 建立編碼本 $\rightarrow$ 全面編碼 $\rightarrow$ 歸納法 (Inductive) 提煉主題。

研究對象基本特徵 ($N = 17$)：完整特徵表

以下為納入研究的 17 位家屬之完整臨床特徵表（可使用滑鼠滾動檢視完整內容）：

關係	年齡	患者狀態	ICU 住院天數	主要入院原因	PCL-5 分數 (3 / 6個月)
兒子 (Son)	35	存活 (Alive)	29天	急性呼吸窘迫 (ARD)	24 / 14
女兒 (Daughter)	61	死亡 (Deceased)	19天	多器官衰竭 (MOF)	29 / 21
妻子 (Wife)	46	死亡 (Deceased)	3天	急性呼吸窘迫 (ARD)	29 / 缺失
妹妹 (Sister)	22	死亡 (Deceased)	55天	急性呼吸窘迫 (ARD)	34 / 29
孫女 (Grand-daughter)	22	死亡 (Deceased)	38天	神經系統病因	33 / 19
母親 (Mother)	54	存活 (Alive)	25天	敗血症 (Sepsis)	29 / 10
妻子 (Wife)	55	死亡 (Deceased)	9天	術後併發症	29 / 23
兒子 (Son)	29	存活 (Alive)	25天	急性呼吸窘迫 (ARD)	30 / 24

研究對象基本特徵 ($N = 17$)：特徵彙總與整理

本研究納入來自法國 14 家 ICU 的 17 位家屬，其特徵如下：

1. 家屬基本特徵

親屬關係	女兒 (7), 妻子 (5), 兒子 (2), 丈夫 (2), 妹妹 (1), 孫女 (1)
年齡分佈	平均 45 歲 (範圍 21–70 歲)
PTSD 評估 (PCL-5)	所有親屬在 3 及 6 個月皆呈臨床顯著症狀 (平均分數 > 29)

2. 患者臨床特徵

病人結局	存活 9 位 (53%) · 在 ICU 內死亡 8 位 (47%)
ICU 住院天數	平均 19 天 (範圍 3–55 天)
主要入院原因	急性呼吸窘迫 (ARD), 休克, 敗血症, 腦中風, 心肺驟停等

主要研究發現：累積效應與三大核心主題 (Major Findings Overview)

研究的核心發現推翻了「單一災難性事件導致創傷」的傳統認知。

核心機制：壓力源的累積性模型 (Cumulative Model)

家屬的 PTSD 症狀並非由單一事件決定，而是整個患病與治療軌跡中多個創傷性壓力源的不斷累積與交織所導致。



1. 生命軌跡與ICU入院

涵蓋入院前長期照護的慢性耗竭、突發事件的劇烈衝擊，以及因「未能及時預防」產生的自責感。



2. 適應ICU環境的博弈

陌生且具「侵略性」的醫療設備、家庭角色的剝奪感、目睹親人與其他患者的痛苦、以及等待的焦慮。



3. 臨終與死亡的震撼

(僅針對死亡組) 撤除維生醫療的決策壓力、親眼目睹死亡瞬間的生理徵象，以及遺體帶來的感官衝擊。

主題一：生命軌跡與 ICU 入院——慢性病程之煎熬

「他有心臟病.....近年來身體每下愈況.....每次進加護病房，我們都會無比擔心」心想『他這次能撐得過去嗎？』

— 家屬訪談記錄 (Inclusion Code: 60-0004)

「在過去兩三年，他開始出現焦慮和恐慌症狀.....他特別害怕死亡」害怕未來將面臨的決定。」

— 家屬訪談記錄 (Inclusion Code: 21-0007)



臨床概念與主題分析

- 入院前的慢性心理消耗：進入 ICU 前，家屬往往已長期承受反覆照護的消耗，心理防禦已被削弱。
- 不確定性的陰影：患者慢性病程的反覆波動，將家屬置於對死亡恐懼的持續警覺狀態中。

主題一：生命軌跡與 ICU 入院——急性突發衝擊

「這一切發生得太突然了……我衝到加護病房，看到他情況非常糟糕。他顯得無比虛弱，而且突然之間，他的身上被接上了所有的儀器和管子。」

— 家屬訪談記錄 (Inclusion Code: 06-0014)



臨床概念與主題分析

- 病程起點的創傷印記：急性事件的突然爆發瞬間中斷了親屬原有的生活軌跡，使其進入「停擺狀態」。
- 技術環境的初次震驚：家屬毫無心理準備地目睹親人被管路、監護儀器所包圍，形成強烈的第一視覺衝擊。

主題一：家屬的自責感與社會角色壓抑

「對於胸外按壓（CPR），我總是在想：『我真的把一切都做對了嗎？**是不是我害了他？**』這種想法持續了很久。」

— 家屬訪談記錄（Inclusion Code: 51-0017）

「我沒有時間去恐慌或整理思緒.....我感到害怕，但我必須保持冷靜，因為在這個家裡我需要扮演那個『**撐住大局的成年人**』。」

— 家屬訪談記錄（Inclusion Code: 21-0013）



臨床概念與主題分析

- 自責感與後悔 (Guilt & Regret)：對未能及時察覺親人病情變化、或對簽署心肺復甦等介入決策反覆拷問，導致創傷深植。
- 情緒抑制 (Emotional Suppression)：為維持家庭穩定強裝冷靜，情感無法在 ICU 期間獲得宣洩，埋下日後遲發性 PTSD 的種子。

主題二：適應 ICU 環境——「另一個世界」與物理視覺創傷

「這對他來說是種**酷刑**，而對我們來說，看到他那個樣子也是種酷刑——無法移動、無法說話、嘴巴張得大大的、雙手被綁著.....」

— 家屬訪談記錄 (Inclusion Code: 60-0014)

「第一晚我姊姊不讓我進去看他，她說：『我不建議你去看他，他身上接滿了管子，而且到處都是血。』.....那情景真的讓我**無比震驚**。」

— 家屬訪談記錄 (Inclusion Code: 60-0004)



臨床概念與主題分析

- 技術環境的「暴力感 (Violence)」：插管、約束帶、血跡等高度生理侵略性的環境，對家屬是嚴重的感官過載與創傷記憶。
- 限制性看視的震驚：對病床旁環境缺乏預備，首日親眼目睹高度醫療化的親人，易誘發強烈的恐怖幻想。

主題二：親人身體異化與無力感

「這真的非常悲慘.....看著你母親幾乎赤裸地躺在那裡，**全身到處是瘀青**，雙手乾癢.....那真的非常痛苦。」

— 家屬訪談記錄 (Inclusion Code: 57-0007)

「看著她那樣昏迷、熟睡，我不知道她能不能聽到我們說話.....我們能看到她在哭、面露痛苦，我們卻**無能為力**。」

— 家屬訪談記錄 (Inclusion Code: 45-0018)



臨床概念與主題分析

- 親人身體的「異化 (Alienation)」：淤青、水腫、赤裸等狀態，破壞了家屬記憶中親人的尊嚴形象。
- 昏迷狀態下的「投射痛苦」：目睹昏迷患者面部抽搐，家屬常會代入並投射其痛苦，加劇其替代性受苦 (Vicarious suffering)。

主題二：親人關係的質變與角色喪失

「我很習慣在家照顧我丈夫，但在這裡，我覺得自己像是被『**隨手扔掉的垃圾**』。我們在那裡好像沒有任何權利，我試圖幫他做點什麼，卻被告知：『那是我們的工作，不再是你的了。』」

— 家屬訪談記錄 (Inclusion Code: 53-0001)



臨床概念與主題分析

- **照顧者角色的剝奪 (Role Deprivation)**：醫療團隊完全接管患者，若醫護言語中缺乏敏感度，會使家屬感到無用與徹底邊緣化。
- **關係親密性的切斷**：親人身體異化（術後腫脹、多管留置）加上儀器阻隔，使原有的家庭親密感產生巨大撕裂。

主題二：替代性受苦與候診室情緒傳染

「在 ICU 的候診室裡，我看到了其他處於同樣境地的人——等待、掙扎、受苦。在那種時刻，家庭與家庭之間發生了某種非常強烈的情緒共振……這深深地傷害了我的女兒。」

— 家屬訪談記錄 (Inclusion Code: 22-0010)

「最痛苦的是候診室……那裡有太多的眼淚，人們都在哭泣，甚至有時候聽到慘叫聲。這對我造成了非常嚴重的二次創傷。」

— 家屬訪談記錄 (Inclusion Code: 45-0018)



臨床概念與主題分析

- 替代性受苦 (Vicarious Suffering)：家屬不僅為親人受苦，也因目睹相鄰病床的緊急搶救或拔管而感到恐慌。
- 情緒傳染 (Emotional Contagion)：候診室是一個悲傷與絕望被放大的封閉空間，家屬會在此被動吸收他人的不幸，削弱其面對自身變故的心理防禦。

主題二：臨床溝通的打擊與冷漠對待

「第一次家族會議簡直像被重鎚擊中。醫生冷冰冰地說：『即使她醒來，也需要換心。』這話太殘忍了，雖然很清楚，但真的讓我大受打擊。」

— 家屬訪談記錄 (Inclusion Code: 51-0017)

「要在加護病房見到醫生太難了。我下午 1 點就到了，一直等到晚上 7 點，醫生還是沒來。這 6 個小時的等待讓我覺得自己無足輕重……」

— 家屬訪談記錄 (Inclusion Code: 53-0001)



臨床概念與主題分析

- 溝通中的同理心缺失：缺乏鋪墊的、冷若冰霜的醫學事實宣告，常演化為家屬心理的二次重創。
- 無效等待與無價值感：醫療團隊長時間失約，會讓家屬產生被忽視的孤立感，質疑醫院的照護誠意。

主題二：希望的雲霄飛車與患者譫妄衝擊

「當她醒來時，情況非常糟糕，她完全不認得我們，還一直在辱罵我們.....她整個人都變了。看到她那樣，我們甚至在想：『如果她醒來後永遠是這種植物人或者瘋癲狀態，那該怎麼辦？』」

— 家屬訪談記錄 (Inclusion Code: 51-0022 / 12-0007)



臨床概念與主題分析

- **生理甦醒與期待落差**：家屬通常將「病人清醒」等同於勝利。然而伴隨的甦醒期譫妄、精神運動性興奮或妄想，往往打破這一期待。
- **人格劇變的恐懼**：目睹親人對醫護破口大罵或表現怪異，引發家屬對其預後生活與精神完整性的極度焦慮。

主題二：緩和和心理衝擊的關鍵因子 (Supportive Buffers)

儘管 ICU 環境充滿壓力，但特定的臨床實踐與護理細節能發揮顯著的創傷保護作用。

1. 環境的「馴服」與個人化

- 允許家屬將親人的照片、個人物品或喜愛的音樂帶入病房，有助於重建「家」的溫馨感。
- 這不僅幫助家屬重拾照顧者角色，也能提醒醫護：這個插管的病人是一個有故事、被愛著的個體。

2. Empathy — 醫護的同理與主動聯絡

- 資訊的及時透明能消弭不確定性；而非言語的同理心（如一個微笑、搭一搭肩膀、耐心的傾聽），其撫慰效果甚至超過單純的醫學解釋。
- 允許家屬隨時電話詢問，能大幅降低他們不在醫院時的極度焦慮。

主題三：臨終與死亡——撤除維生醫療的決策與誤解

「醫生告訴我：『我們需要決定停掉機器。但請記住，做出這個決定的是我們醫療團隊，而不是家屬。』聽到這話，我心裡一塊大石頭落了地。這太重要了，沒有人需要為此承擔**罪惡感**。」

— 家屬訪談記錄 (Inclusion Code: 51-0022)

「醫院打給我祖母說他呼吸太困難了，如果家屬同意，他們打算『**讓他安樂死**』……我懷疑他們是給他注射了過量藥物。」

— 家屬訪談記錄 (Inclusion Code: 21-0013)

臨床概念與主題分析

- 決策界線宣告的保護力：醫學判斷撤除維生醫療 (WWLST) 為醫療判斷而非家屬選擇，能解除家屬對「共謀殺害」親人的心靈重擔。
- 臨終鎮靜與安樂死的混淆：不良溝通易使家屬將控制不適的鎮靜劑 (Sedatives) 解讀為「故意安樂死」或過量殺害，形成沉重的長期陰影。

主題三：臨終關懷與溫馨告別的契機

「他們讓我陪他度過最後一夜。護士用手電筒照明，避免打開大燈吵醒我。真的很體貼.....這是最後一個晚上，知道他要走了，但我們確實分享了**充滿愛的連結**。我希望能一直留著這個回憶。」

— 家屬訪談記錄 (Inclusion Code: 51-0002)



臨床概念與主題分析

- **時間的「可控性」與心理準備**：在明確得知親人將臨終後，給予家屬不受干擾、充裕的陪伴空間，有助於進行「預期性哀傷 (Anticipatory grief) 」的整合。
- **非語言的人道體貼**：醫護團隊對臨終環境技術印記的最小化 (如深夜不開大燈、腳步放輕)，能為親屬留下溫暖的「臨終敘事」，減輕創傷。

主題三：臨終時的醫療設備與視覺折磨

「他們沒有關掉監護儀，就那樣亮著。我盯著螢幕，看著心跳一下一下變慢，整個人都要崩潰了。我父親讓護士關掉，護士居然還反問『為什麼？』並拒絕立刻關閉……這太殘忍了。」

— 家屬訪談記錄 (Inclusion Code: 21-0007)



臨床概念與主題分析

- 技術去人性化的極致創傷：盯著監護儀心跳波形至「平線 (Flatline) 」的過程，極易轉化為反覆閃回 (Flashback) 的夢魘。
- 醫護團隊的常規冷漠：將生命徵象監測儀當作常規不予關閉，反映出團隊對臨終情境下家屬視覺衝擊的阻隔。

主題三：臨終時間的拉扯與遺體感官震撼

「我以為幾分鐘就會結束，但過程比我想的要長.....我們一方面不捨得他走，另一方面又急著希望這一切快結束，別讓他受苦了。他的呼吸斷斷續續，**非常煎熬**。」

— 家屬訪談記錄 (Inclusion Code: 21-0013)

「我單獨留在房間，鼓起勇氣走過去摸他.....他**好冰冷、好僵硬**。那太可怕了，而且那種味道.....這些感官體驗一直留在我的腦袋深處。」

— 家屬訪談記錄 (Inclusion Code: 25-0007)



臨床概念與主題分析

- 臨終時長的不確定性：不規則的瀕死呼吸（如潮式呼吸）易引發家屬的情緒撕扯（既不捨又希望患者早日解脫）。
- 死後遺體的物理衝擊 (Post-mortem Shock)：冰冷、僵硬、氣味等感官細節，對於首次接觸死亡的家屬，會留下深沉的病理性記憶。

討論：創傷累積模型 (The Cumulative Stress Model)

本研究的理論貢獻在於建構了 ICU 經歷與家屬心理創傷之間的動態模型。

1. 創傷形成的動態軌跡

- **背景易感期**：前期的照顧疲勞、個人創傷歷史。
- **急性衝擊期**：突然的入院、對技術環境的恐懼、自責。
- **環境博弈期**：關係被剝奪、替代性受苦、甦醒譫妄。
- **臨終決策期**：決策拉扯、生理臨終視覺衝擊。

👉 創傷是上述壓力源沿時間軸不斷疊加 (Additive Effect) 的結果。

💡 ICU 的雙重隱喻 (The ICU Ambivalence)

加護病房對家屬而言扮演了**雙重角色**：

- **作為創傷源 (Source of Trauma)**：高度技術化、充滿噪聲、見證痛苦與死亡的「修羅場」。
- **作為避風港 (Place of Reassurance)**：擁有強大醫療資源、能快速應對變化、提供安全感與人性關懷的場所。

臨床實踐的目標，正是將 ICU 從單純的創傷源，最大程度地轉化為提供支持**的避風港**。

臨床啟示：加護病房團隊的實務建議 (Clinical Implications)

作為 ICU 專門醫師，我們應當如何優化日常臨床工作以降低家屬的 PTSD 風險？

1. 改善日常溝通與角色重建

- **主動且一致的資訊共享**：避免不同班次醫護說法不一導致家屬無所適從。
- **引導家屬參與輕度護理**：如幫親人擦臉、抹潤唇膏、按摩雙手。用具體行動重建其「照護者角色」，消弭被排斥感。
- **預防性解釋甦醒期譫妄**：在減藥或拔管前，明確告知家屬「患者可能會出現躁動、胡言亂語或短暫的人格改變，這是藥物代謝的正常現象，不代表大腦永久受損」。

2. 優化臨終與死亡處置流程

- **界定決策責任**：向家屬強調 WWLST 是「醫療團隊做出的醫學決定」，家屬的任務是幫助我們理解患者的意願，而非按下「停止鍵」。
- **「視覺與聽覺的去技術化」**：在撤除維生設備時，務必關閉病房內的所有儀器螢幕與報警音。
- **瀕死徵象的預先衛教**：向家屬預告可能出現的喘息 (Gasping) 或肌肉反射，說明這通常是無意識的生理現象，患者此時已處於深度鎮靜，並無痛苦。

研究限制與局限性 (Limitations)

我們在將此研究結論應用於本科室臨床實踐時，需注意以下局限性：

1. 外推性限制 (Generalizability)

- 本研究受試者皆來自法國醫療體系，其文化背景（如對死亡的態度、家庭架構）與東亞文化可能存在差異。
- 受試者皆為法語使用者，可能無法完全代表少數族裔或移民家庭的經歷。

2. 選擇性偏差與對照缺失 (Selection Bias)

- 研究僅訪談了「已出現顯著 PTSD 症狀」的家屬。
- 未納入「同樣經歷 ICU 卻未發展出 PTSD 症狀」的家屬作為對照組，因此無法確切區分哪些是「特異性觸發點」，哪些是「普遍性經歷」。

💡 **東亞文化背景下的反思：**在我們的臨床環境中，家屬對於 WWLST 的「孝道壓力」與決策內疚感可能更為沉重。醫療團隊承擔決策責任的宣示 ("It is our medical decision") 在我們的文化脈絡下可能更具保護作用。

結語與臨床反思 (Take-home Messages)

「這對他來說是種折磨，而看到他那樣對我們來說也是種折磨。」

核心提要：

- 家屬的 PTSD 不是單一事件引起的，而是整個 ICU 住院軌跡中壓力的**累積效應**。
- 我們在專注於器官功能維護、各項導管留置與實驗室數據的同時，必須意識到**每一次病床旁的查房、每一次談話、甚至每一次儀器警報，都在塑造家屬的創傷記憶**。
- 落實「預先衛教（甦醒譫妄、瀕死徵象）」、「關閉臨終儀器螢幕」與「釐清醫療決策邊界」是每位 ICU 專門醫師伸手可及、能切實減輕家屬創傷的臨床武器。

Thank you for your attention. Open for discussion.